Диагностическая консультация при запросе на снижение веса

Практический конспект для подготовки сильного консультанта и последующего проектирования AI Lead Bot

Исследовательская редакция • 13 октября 2026 • Основано на открытых профессиональных руководствах и двух предоставленных концептуальных материалах проекта.

Короткий вывод

Сильный консультант не «выкапывает скрытую травму» любой ценой. Он вместе с человеком восстанавливает, что происходит, почему это может происходить, что поддерживает трудность, как она влияет на жизнь и какие изменения действительно важны. Он умеет пользоваться типичными профессиональными гипотезами, но не превращает их в чужую биографию. Самая ценная единица разговора — не вопрос и не объяснение, а проверяемое улучшение понимания.

Этот материал — методика беседы и рабочая карта гипотез, а не инструкция ставить психологические или медицинские диагнозы. Нельзя исходить из того, что лишний вес всегда имеет психологическую «первопричину»: значимы физиология, лекарства, сон, доступность еды, экономика, условия работы, привычки и социальная среда.

1. Что именно мы заимствуем из разных школ

Подход	Что берём для диагностики	Чего не переносим механически
Motivational Interviewing (мотивационное интервьюирование)	Партнёрство; отражения; работа с противоречиями и собственной мотивацией; Elicit–Provide–Elicit (спросить — сообщить — узнать реакцию).	Не превращаем каждую беседу в «раскачивание» мотивации и не используем вопросы для скрытого давления.
CBT case formulation (когнитивно-поведенческая формулировка случая)	Ситуация → мысли → эмоции/телесные ощущения → действие → краткосрочные и долгосрочные последствия; поддерживающие циклы.	Не ставим диагнозы, не интерпретируем детство без оснований и не проводим терапию.
Functional analysis (функциональный анализ поведения)	Что было до эпизода, что человек сделал, что получил сразу и что	Не предполагаем, что каждое переедание — эмоциональная

	произошло позднее.	компенсация.
COM-B (возможности, условия и мотивация поведения)	Разделяем «не умею», «не могу в текущих условиях», «не хочу/не готов», привычку и автоматические реакции.	Не сводим трудности к силе воли.
SPIN Selling (метод СПИН-продаж)	От контекста и затруднения — к последствиям и личной ценности изменений.	Не усиливаем страх, стыд и болезненные переживания ради продажи.
5As of Obesity Management (пять шагов работы с ожирением)	Ask, Assess, Advise, Agree, Assist (спросить разрешение, оценить, предложить информацию, согласовать, помочь).	Не изображаем медицинскую оценку, которую чат-бот не проводил.

2. Контракт хорошей диагностической беседы

- Человек остаётся главным источником знаний о своей жизни; консультант приносит карту типичных механизмов и умение различать их.
- Любое содержательное предположение имеет статус гипотезы до подтверждения. Коррекция человека сильнее красивой теории.
- Консультант не спрашивает «что вас беспокоит?» в пустоту, если человек не может назвать это; предлагает 2–3 уместные версии и вариант «ни одна».
- Каждый ход должен иметь функцию: укрепить контакт, уточнить ключевую неизвестность, проверить гипотезу, связать элементы, раскрыть личный смысл, определить следующий шаг.
- Не требуется задавать вопрос в каждом сообщении; но и вопрос в каждом сообщении не является ошибкой, если каждый имеет смысл.
- Простое отражение иногда нужно для контакта; сложное отражение может добавить осторожную интерпретацию. Нельзя требовать новизну любой ценой.
- Не угадывать интимные, социальные и бытовые ограничения по весу или внешности. Предлагать их как возможные примеры, с разрешением не соглашаться.
- Не выдавать медицинскую, психиатрическую или психологическую диагностику за результат беседы; распознавать ситуации, требующие специалиста.
- Не путать глубокое понимание с глубиной вторжения: уважать границы, не требовать откровенности и не использовать её для давления на покупку.

3. Карта диагностических областей — не анкета, а навигация

Область	Что понять	Примеры полезных

		направлений
Запрос и контекст	Почему человек обратился сейчас, что считает проблемой	«Что стало последней каплей?»; «Что хотелось бы изменить в обычной жизни?»
История веса и изменений	Когда началось, как менялось, были ли поворотные события	Периоды набора/снижения, изменения режима, лекарства, жизненные события
Поведение и среда	Когда и в каких условиях трудность проявляется	Ритм питания, работа, сон, доступность еды, семейные привычки
Цикл эпизода	Что предшествует, происходит и следует за конкретным случаем	Голод, усталость, эмоции, автоматизм, мысли после эпизода
Предыдущие попытки	Что помогало, что не выдерживало нагрузку, что было слишком дорого	Срывы, ограничения, устойчивость, поддержка, возврат после отклонения
Убеждения и самоотношение	Как человек объясняет происходящее себе	«У меня нет силы воли», «если нарушил — всё пропало», стыд
Жизненные ограничения	Что человек перестал делать, выбирать или позволять себе	Одежда, фотографии, движение, досуг, близость — только как гипотезы
Ресурсы и исключения	Когда проблема меньше и почему	Удачные дни, возвращение к плану, поддерживающие обстоятельства
Ценность изменений	Что изменится лично для него	Свобода выбора, энергия, здоровье, участие в жизни, уверенность
Готовность и следующий шаг	Что человеку подходит сейчас	Желание исследовать, помощь специалиста, практические ограничения

4. Метод работы с одним эпизодом: от рассказа к механизму

1. Попросить один конкретный недавний пример вместо общего «всегда так».
2. Восстановить контекст: когда, где, после какого дня, с кем, что было доступно, что происходило с голодом и усталостью.
3. Различить событие и интерпретацию: «съел больше» — событие; «всё испортил» — оценка.

4. Понять функцию поведения: что оно дало сразу — сытость, отдых, удовольствие, снятие напряжения, социальное участие? Не предполагать заранее.
5. Понять последствия: что изменилось через час, утром, через неделю; что удерживает цикл.
6. Сопоставить 2–3 конкурирующие гипотезы и выбрать один различающий вопрос или осторожное объяснение.
7. Проверить с человеком: «это похоже или я промахнулся?»; обновить картину при несогласии.
8. Найти исключение: когда было иначе и какие условия помогли.
9. Связать механизм с личным смыслом и возможным направлением помощи, не выдавая план лечения.

5. Банк механизмов: что искать, как различать, чего не предполагать

Возможный механизм	Подсказки в рассказе	Диагностически полезный вопрос / предложение
Физический голод после ограничений	Пропуски еды, очень длинные интервалы, выраженный вечерний голод	«Вечером больше ощущается сильный голод или желание расслабиться — или оба?»
Эмоциональная регуляция едой	Эпизоды после напряжения, одиночества, конфликтов	«Что еда даёт в первые минуты: спокойствие, паузу, удовольствие или просто насыщение?»
Чёрно-белая оценка результата	«Всё испортил», «начну заново», длительные паузы после эпизода	«Похоже, один вечер становится оценкой всей попытки. Это про вас?»
Слишком жёсткие правила	Запреты, компенсация, трудность гибко вернуться	«После отклонения вы возвращаетесь к привычному режиму или чувствуете, что надо всё начинать заново?»
Недостаток условий, а не мотивации	Непредсказуемая работа, бюджет, семейные обязанности	«Если бы желание было тем же, что мешало бы на практике?»
Привычка и сигналы среды	Автоматические перекусы, еда перед экраном	«В какой момент замечаете, что уже начали есть?»
Недостаток сна / усталость	Смены, короткий сон, истощение	«Это происходит чаще после недосыпа или и в спокойные дни?»

Стыд и самокритика	Скрытность, самообвинение, избегание контактов	«Что вы говорите себе после такого случая?»
Ожидания и разочарование	«Стараюсь, а ничего не меняется»	«По чему вы обычно понимаете, что попытка работает?»
Социальные сценарии	Семейные застолья, давление окружения	«В каких ситуациях сложнее действовать по-своему?»
Избегание из-за дискомфорта или самооценки	Сужение активности, отказ от фото/одежды/мероприятий	«Есть ли что-то, что раньше нравилось, а теперь стало менее доступным? Или это не про вас?»
Медицинские/ лекарственные факторы	Резкие изменения, симптомы, новые лекарства	«Были ли изменения здоровья или лечения, которые стоит обсудить с врачом?»

Одна ситуация может иметь несколько механизмов. Некоторые механизмы не психологические. Нельзя выбирать гипотезу только потому, что она эмоционально эффектно звучит.

6. Как предлагать варианты человеку, который сам не знает ответа

Рабочий приём: признать факт → назвать область неопределённости → предложить 2–3 конкретные, различающиеся версии → оставить открытый выход → дождаться коррекции. Варианты берутся из релевантного профессионального опыта, а не из универсального списка «болей».

Пример. «Понял, на следующий день вы возвращаетесь к привычному режиму. Тогда трудность может быть в другом: иногда остаётся чувство вины, иногда тревожит повторение, а иногда больше расстраивает, что прогресс идёт медленно. Что-нибудь похоже на вашу ситуацию — или дело совсем в другом?»

Если человек отвечает «не знаю», не повторять вопрос другими словами. Можно попросить сравнить два конкретных эпизода, предложить один жизненный пример или оставить тему без давления.

Риск: варианты могут подсказать человеку ложный ответ. Поэтому ограничивать их количество, не перечислять драматичные переживания без основания и считать согласие лишь предварительным подтверждением.

7. Профессиональные ходы: как выбирать

Ход	Когда полезен	Когда мешает
Открытый вопрос	Нужен широкий рассказ, направление неясно	Человек уже не может сформулировать ответ
Вопрос-различитель	Есть 2–3 правдоподобных механизма	Альтернативы искусственные или навязаны
Сложное отражение	Есть обоснованная связь, которую можно показать	Это выдаётся как установленная правда
Короткая профессиональная информация	Человек заблуждается или ему не хватает карты вариантов	Превращается в лекцию без связи с опытом
Предложение типичных вариантов	Человек затрудняется распознать собственное состояние	Список слишком длинный или содержит чужую биографию
Уточнение/принятие коррекции	Изменился существенный факт	Бот начинает защищать старую гипотезу
Обобщение	Накоплено несколько важных связей	Преждевременно объявляет «корень проблемы»
Пауза/открытое продолжение	Тема эмоционально насыщена	Бот искусственно заполняет каждую паузу вопросом

8. Глубина: как дойти до поддерживающего механизма, не выдумав «корень»

Уровень 1 — событие: «вечером переел». Уровень 2 — условия: «после пропущенного обеда и тяжёлого дня». Уровень 3 — функция: «хотел насытиться и наконец отдохнуть». Уровень 4 — интерпретация: «раз нарушил — ничего не получилось». Уровень 5 — цикл: «после самообвинения прекращаю попытки». Уровень 6 — личный смысл: «перестаю доверять себе и избегаю новых попыток».

Это не обязательная лестница. В конкретной беседе реальный «корень» может оказаться сменным графиком, дефицитом сна, лекарством, хроническим стрессом, ограничительным питанием или сочетанием факторов. Не искать детскую травму, страх близости или низкую самооценку без данных.

Проверочный вопрос консультанта к самому себе: «Какой факт мог бы показать, что моя красивая гипотеза неверна?» Если такого факта нет, гипотеза плохо проверяема.

9. Особая ценность: скрытые бытовые ограничения и изменение картины жизни

Из пользовательского концептуального документа проекта: человек может адаптировать предпочтения к ограничениям — например, объяснять отказ от походов любовью к комфорту, хотя иногда ему просто тяжело идти; аналогично возможны одежда, фотографии, танцы, общение и близость. Это полезная исследовательская гипотеза, но не универсальная правда.

Лучший формат — осторожный сюжет для узнавания: «Иногда человек постепенно перестаёт выбирать то, что раньше любил, и объясняет это сменой интересов. Например, походы: может быть, они и правда разонравились, а может, сложнее стало добираться до места. Случалось ли что-то похожее у вас — или нет?»

Не изображать собственный пережитый опыт («я сам это проходил»), если его нет. Не утверждать, что человек испытывает сексуальные или семейные проблемы только из-за веса. Не выдавать вымышленные вероятности вроде 82% избегания фотографий за статистику.

10. Личная ценность перемен без давления

Исследовать не только «от чего уйти», но и «ради чего двигаться»: свободнее передвигаться, легче играть с детьми, спокойнее относиться к еде, выбирать одежду, больше участвовать в жизни, заботиться о здоровье. Не обещать, что снижение веса автоматически даст счастье, сексуальную привлекательность, энергию или решит отношения.

SPIN-подход помогает обсуждать последствия и ценность изменений. Однако искусственное усиление страха, стыда или угрозы будущего ради продажи противоречит безопасной и уважительной консультации. Реальные медицинские риски обсуждаются соразмерно, без запугивания и ложной срочности.

11. Переход к живому консультанту

Переход уместен, когда человек понимает, что было выяснено, что осталось неопределённым, зачем может быть полезен следующий разговор и добровольно согласен. Экспертность демонстрируется качеством самой беседы, а не неподтверждёнными заявлениями «мы помогли сотням».

Передаваемое резюме: цель человека; его собственные слова о трудностях; подтверждённые факты; рабочие гипотезы с пометкой «не подтверждено»; прежние попытки; выявленные барьеры; важные предпочтения; согласованный следующий шаг. Не передавать интимные и медицинские детали сверх необходимого и согласованного.

12. Красные флаги и границы компетенции

- Подозрение на расстройство пищевого поведения: повторные эпизоды потери контроля, сильный дистресс, очищающее поведение, чрезмерные ограничения. Не назначать диету и не пытаться лечить в чате; предложить профильного специалиста.
- Резкие необъяснимые изменения веса, выраженные симптомы, подозрение на лекарственные или эндокринные причины: направить на медицинскую оценку.
- Сильная депрессия, травматические переживания, риск причинения себе вреда: не вести «глубинную проработку» ради продажи, переключиться на соответствующую поддержку.
- Стыд, дискриминация по весу, самоуничижение: не усиливать их; не считать вес объяснением всех проблем.
- Не давать индивидуальные назначения, диагнозы и гарантии результатов. Человек вправе не обсуждать чувствительную тему.

13. Полные примеры диагностических мини-диалогов

Случай A. Переедание → «всё испортил»

Пользователь: «После тяжёлой недели пропускаю обед, вечером переедаю. Потом думаю, что всё испортил, и бросаю на недели».

Консультант: «Похоже, тут могут накладываться две вещи: после пропущенного обеда вечером трудно остановиться, а мысль “всё испортил” превращает один вечер в длительную паузу. Какая из этих частей больше мешает — или я неверно связал события?»

Пользователь: «Скорее второе».

Консультант: «Тогда интересно не столько, как избежать каждого переедания, сколько что делает один эпизод для вас окончательным провалом. Бывает, что после такого вечера вы всё же продолжаете?»

Смысл: гипотеза разделяет физиологический и оценочный механизмы; следующий вопрос ищет исключение, а не повторяет факты.

Случай B. Пользователь исправляет факт

Пользователь: «Нет, я не бросаю. На следующий день возвращаюсь к режиму».

Консультант: «Понял, значит, я неверно предположил длительный срыв. Вы возвращаетесь к режиму — это важная разница. Тогда что остаётся неприятным: вина после эпизода, страх повторения, отсутствие заметного результата? Или вообще не это?»

Пользователь: «Меня бесит, что результата не видно».

Консультант: «Тогда дело, возможно, больше в разрыве между усилиями и ожидаемым результатом. Как вы обычно понимаете, что усилия работают?»

Смысл: гипотеза изменена; база типичных вариантов помогает человеку назвать реальную трудность.

Случай C. «Не люблю походы»

Пользователь: «Раньше ходил в горы, сейчас вообще не люблю».

Консультант: «Вкусы правда могут меняться. Но иногда человек начинает меньше любить занятие, когда оно стало физически тяжелее. У вас скорее изменился интерес к походам или само удовольствие осталось, а добираться стало сложнее?»

Пользователь: «Само удовольствие осталось, но подниматься тяжело».

Консультант: «То есть речь не о том, что вы разлюбили горы, а о том, что путь к ним стал менее доступным. Это может быть важной личной причиной изменений».

Смысл: бытовая гипотеза становится подтверждённой только после ответа.

Случай D. «Не знаю, почему ем вечером»

Пользователь: «Не знаю. День был обычный».

Консультант: «Это нормально, что причина не очевидна. Иногда дело в голоде, иногда в привычном вечернем ритуале, иногда в потребности переключиться. Если вспомнить вчерашний вечер: вы были физически голодны, начали есть автоматически или искали способ расслабиться? Можно и не выбрать ни один вариант».

Смысл: варианты помогают наблюдать опыт; отсутствие ответа допустимо.

14. Как оценивать качество консультации

Критерий	Вопрос оценщика	Признак провала
Точность понимания	Правильно ли удержаны и исправлены факты?	Старая гипотеза пережила прямое опровержение
Полезность хода	Что человек узнал/прояснил после реплики?	Пересказ без функции либо бесцельный вопрос
Обоснованность гипотез	На каких фактах и профессиональных знаниях она основана?	Уверенное чтение мыслей
Диагностическая различимость	Поможет ли ответ различить возможные механизмы?	Вопрос, ответ на который ничего не меняет
Помощь в распознавании	Получил ли человек уместные варианты, если не мог сформулировать?	«Что вас беспокоит?» повторяется без помощи
Уважение к автономии	Можно ли не согласиться и отказаться?	Скрытое давление или внушение

Естественность	Похоже ли на живой разговор, а не анкету?	Одинаковые конструкции и вопросы каждый ход
Глубина без фантазирования	Дошли ли до поддерживающего механизма, не выдумав корень?	Спекуляции о травмах, отношениях, самооценке
Безопасность	Не пропущены ли основания для профессиональной помощи?	Продажа вместо реакции на красный флаг
Ценность следующего шага	Понятно ли человеку, зачем продолжать?	Необоснованная передача в продажи

Рекомендуемая проверка: оценивать не отдельные реплики в вакууме, а короткие ветвящиеся диалоги. Одинаковая фраза может быть хорошей после одного контекста и плохой после другого. Нельзя считать субъективные баллы автоматическим доказательством эффективности.

15. Практическая программа обучения консультанта

10. Урок 1. Учиться слушать и отделять факт от интерпретации: разметить 15 коротких рассказов.
11. Урок 2. Освоить функциональный разбор конкретного эпизода: контекст, функция, последствия, цикл.
12. Урок 3. По каждому рассказу строить три конкурирующие гипотезы и один различающий вопрос.
13. Урок 4. Тренировать «помощь в распознавании»: 2–3 типичных варианта плюс открытый выход.
14. Урок 5. Тренировать исправления: мгновенно отказываться от опровергнутой версии, не защищать её.
15. Урок 6. Тренировать сложные отражения и короткие объяснения без категоричности.
16. Урок 7. Учиться исследовать повседневные ограничения и желаемую жизнь без приписывания чужого опыта.
17. Урок 8. Отрабатывать красные флаги, границы и согласованную передачу человеку-специалисту.
18. Экзамен. 8–12 ветвящихся случаев, включая противоречия, «не знаю», отказ, сильные эмоции, медицинские признаки и ложные соблазнительные гипотезы.

16. Что из двух материалов проекта сохранено, а что переосмыслено

Из «Моё видение бота»: сохранить живое бытовое описание ситуации, узнавание неозвученных ограничений, ценность будущих изменений, профессиональную

уверенность и передачу живому консультанту. Переосмыслить «как будто бот сам это пережил», «немного напугать», уверенные догадки по количеству килограммов и эмоциональное давление: вместо этого — честные, проверяемые, деликатные гипотезы и добровольное согласие.

Из «Продажные воронки»: сохранить многомерность качества диалога — доверие, точность, мотивация, экспертность, естественность, готовность к следующему шагу. Не превращать это в десять последовательных «воронок» или автоматические оценки без внешней проверки. Продажа — следствие полезной консультации, а не разрешение манипулировать уязвимостью.

17. Основные источники и что именно из них использовано

MINT — Understanding Motivational Interviewing
https://motivationalinterviewing.org/understanding-motivational-interviewing
Использовано: Партнёрство, OARS, четыре процесса, обмен информацией Elicit–Provide–Elicit.

SAMHSA — Enhancing Motivation for Change, Chapter 3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK571068/
Использовано: Техника вопросов, отражений, обобщений и логика интервью.

Obesity Canada — Adult Clinical Practice Guideline
https://obesitycanada.ca/healthcare-professionals/adult-clinical-practice-guideline/
Использовано: 5As, корневые причины, барьеры, отсутствие стигматизации, ценность качества жизни.

NICE NG246 — General principles of care
https://www.nice.org.uk/guidance/ng246/chapter/General-principles-of-care
Использовано: Контекст, лекарства, психосоциальные факторы, нарушения питания, уважение выбора.

NICE NG246 — Behavioural interventions
https://www.nice.org.uk/guidance/ng246/chapter/Behavioural-overweight-and-obesity-management-interventions
Использовано: Барьеры участия, контекст изменений, поддержка прогресса.

NICE NG69 — Eating disorders
https://www.nice.org.uk/guidance/NG69/chapter/recommendations
Использовано: Границы, признаки РПП, направление к специалистам, особенности переедания.

NIDDK — Binge Eating Disorder
https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/binge-eating-disorder/symptoms-causes

Использовано: Потеря контроля, эмоциональные и поведенческие признаки, многофакторность.

Michie et al. — Behaviour Change Wheel / COM-B
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/3096582/
Использовано: Возможности, условия, мотивация; поведение не равно силе воли.

Huthwaite — SPIN Methodology
https://www.huthwaiteinternational.com/spin-methodology
Использовано: Ситуация, проблема, последствия, ценность изменений; применимо выборочно.

USPSTF — Behavioral Interventions for Weight Loss
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/obesity-in-adults-interventions
Использовано: Многокомпонентность поведенческой помощи, барьеры, профилактика возврата.

Статус и ограничения конспекта

Это синтез для проектирования практики беседы, а не дословное воспроизведение одной утверждённой профессиональной методики. Отдельные примеры и схемы являются авторскими иллюстрациями, не результатами клинических исследований. Источники дают ориентиры, но не доказывают, что конкретная формулировка бота повысит доверие или конверсию. Для этого потребуются тесты с реальными людьми и проверка безопасности.